Actitudes, decúbitos, conciencia, coma y movimientos anormales

SEMIOLOGIA · Clase 06 · lo que dice la postura del paciente antes de tocarlo

1 · MIRAR ANTES DE TOCAR: ECTOSCOPÍA Y DECÚBITO

Ectoscopía (F1)
mirada de conjunto sin instrumentos: inspección y palpación, siempre juntas

- en segundos estima el → **Estado general**: BEG, REG o MEG y nivel de conciencia
- si se mueve solo es → **Decúbito activo**: cambia de posición por voluntad propia
- si no puede moverse es → **Decúbito pasivo** (F6): no puede moverse: masa inerte (coma, adinamia); se mide Glasgow

si la postura es elegida hay → *si el paciente busca alivio adopta* / *en el niño cianótico aparece*

si hay contractura intensa → 3 · POSTURAS QUE IMPONE LA ENFERMEDAD

2 · POSTURAS QUE EL PACIENTE ELIGE PARA ALIVIARSE

Genupectoral (F2)
rodillas, pecho y codos apoyados (plegaria mahometana): pericarditis con derrame

alivia porque

- **Ortopnea**: sentado o semisentado: baja la congestión pulmonar; IC, edema pulmonar, asma, ascitis → orienta como las demás a
- **Alivia el dolor pericárdico** (F2): inclinarse hacia adelante reduce la compresión del corazón (🧩) → orienta a
- **Cuclillas** (F4): el niño la adopta solo: tetralogía de Fallot (cardiopatía cianótica) → orienta a → funciona porque → **Sube la presión abdominal** (F4): más sangre va al pulmón → por eso → Mejora la disnea del niño cianótico

orienta como las demás a + orienta a → La postura elegida orienta a corazón o pulmón

3 · POSTURAS QUE IMPONE LA ENFERMEDAD

Contractura intensa (F5)
de los músculos espinales: arquea todo el cuerpo

si cambia el sentido del arco → *exige medir la conciencia en* 4 · CUANDO NO RESPONDE: CONCIENCIA Y COMA

si arquea hacia atrás

si la enfermedad la impone hay

- **Gatillo de fusil** (F3): lateral, cabeza hiperextendida, piernas flexionadas, tórax encorvado: irritación meníngea → se debe a → **Meningitis infantil** (F3): las meninges irritadas extienden la cabeza y flexionan las piernas → orienta a
- **Opistótonos** (F5): arco hacia atrás, apoyo occipital → se debe a → **Causas** (F5): tétanos, rabia y meningitis → orienta a
- **Otras actitudes**: emprostótonos: arco hacia adelante · ortostótonos: rígido y recto · pleurostótonos: encorvado de lado → orienta a

orienta a → La postura impuesta no alivia: orienta a meninges o tétanos

4 · CUANDO NO RESPONDE: CONCIENCIA Y COMA

Conciencia
continuo: lúcido, somnolencia, estupor, coma

- si se apaga se busca la → **Causas por sistemas** (F6): neurológico, hepático, renal, cardiovascular, endocrino y tóxico
- si la profundidad aumenta hay → **Coma I a IV**: I: atiende órdenes simples · IV: apnea, respirador y silencio eléctrico → se cuantifica con → **Escala de Glasgow**: ocular 4 + motora 6 + verbal 5: 15 lúcido, 3 mínimo → orienta la profundidad del

Causas por sistemas:

- en el cerebro → **Neurológico** (F6): ACV, neoplasia, encefalitis, meningitis, estatus epiléptico → cierra la rama en
- en el hígado → **Hepático** (F7): encefalopatía hepática, grados I a IV; la precede el flapping → su toxicidad cierra en
- en el riñón → **Renal** (F8): encefalopatía urémica: toxinas nitrogenadas deprimen la conciencia → su toxicidad cierra en
- en otros sistemas → **Otras causas** (F6): CV: encefalopatía hipertensiva · endocrino: cetoacidosis, hipoglicemia · tóxico: alcohol, barbitúricos → cierra la rama en

cierra la rama en + su toxicidad cierra en + cierra la rama en → El cerebro se apaga por daño propio u otro órgano que lo intoxica: se busca por sistemas

la precede el → 5 · LAS MANOS QUE SE MUEVEN SOLAS

también da ← Flapping (asterixis) (F9)

5 · LAS MANOS QUE SE MUEVEN SOLAS

Hipocalcemia (F11)
calcio < 8 mg/dL (normal 9-11); hipoparatiroidismo; alcalosis por hiperventilación

produce la

con calcio bajo hay / *al mirar las manos hay*

- **Flapping (asterixis)** (F9): manos en posición de juramento, forzadas hacia atrás: aleteo de ave → aparece en la → **Encefalopatía metabólica** (F9): hepática (precoma) y también urémica → localiza la falla en
- **Corea** (F10): movimientos amplios, desordenados, inesperados de cara y extremidades: ganglios basales → si es posreumática → **Corea de Sydenham** (F10): secuela de fiebre reumática en niñas menores de 15 años (Huntington: hereditaria) → localiza la falla en
- **Tetania** (F11): espasmo carpopedal o mano de partero → se reproduce con el → **Signo de Trousseau** (F11): brazalete inflado unos 10 min reproduce el espasmo → confirma y cierra en

localiza la falla en + confirma y cierra en → Los movimientos de las manos localizan la falla: cerebro intoxicado, ganglios basales o calcio

técnica · concepto · signo · mecanismo · desenlace · diagnóstico · causa · ejemplo · síndrome · borde dorado = alto rendimiento · F# = pregunta n.º # de la lámina

Fuente: Sotomayor — teoría del docente: 05a, 05b, 03 (🧩 = literatura)